

# **EDUKASI MULTI MEDIA INTERAKTIF DAN PENDAMPINGAN KELUARGA**

KONTRIBUSI PENTING KEMAMPUAN KELUARGA DALAM  
DETEKSI DINI RISIKO JATUH PADA LANSIA STROKE

Aan Nurhasanah • Rosidawati • Eros Siti Suryati  
Nurdahlia



# **EDUKASI MULTI MEDIA INTERAKTIF DAN PENDAMPINGAN KELUARGA: KONTRIBUSI PENTING KEMAMPUAN KELUARGA DALAM DETEKSI DINI RISIKO JATUH PADA LANZIA STROKE**

## **Penulis:**

Aan Nurhasanah., S.KM., M.K.M.

Rosidawati S.KM., M.Kes.

Eros Siti Suryati, S.Pd., M.K.M.

Nurdahlia, S.Pd., M.K.M.



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

**Edukasi Multi Media Interaktif Dan Pendampingan Keluarga: Kontribusi Penting Kemampuan Keluarga Dalam Deteksi Dini Risiko Jatuh Pada Lansia Stroke**

**Penulis:** Aan Nurhasanah., S.KM., M.K.M.

Rosidawati S.KM., M.Kes.

Eros Siti Suryati, S.Pd., M.K.M.

Nurdahlia, S.Pd., M.K.M.

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

**Tata Letak:** Muhammad Ilham

**ISBN:** 978-634-7097-56-9

**Cetakan Pertama:** Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2025**

**by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [www.nuansafajarcemerlang.com](http://www.nuansafajarcemerlang.com)

Instagram: @bimbel.optimal



**PENERBIT:**

**Nuansa Fajar Cemerlang**

**Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F**

**Jakarta Barat, 11480**

**Anggota IKAPI (624/DKI/2022)**

**Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

JUDUL DAN  
PENANGGUNG JAWAB

Edukasi multi media interaktif dan pendampingan keluarga : kontribusi penting kemampuan keluarga dalam deteksi dini risiko jatuh pada lansia stroke / Aan Nurhasanah., S.K.M., M.K.M., Rosidawati S.K.M., M.Kes., Eros Siti Suryati, S.Pd., M.K.M., Nurdahlia, S.Pd., M.K.M.

EDISI

Cetakan pertama, Februari 2025

PUBLIKASI  
DESKRIPSI FISIK

Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

IDENTIFIKASI

71 halaman ; 30 cm

SUBJEK

ISBN 978-634-7097-56-9

KLASIFIKASI

Penyakit serebrovaskular -- Usia lanjut - Kesehatan dan kebersihan  
616.81 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1076154>

## PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Illahi Rabbi, karena dengan qada dan iradat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan monograf yang berjudul” **Edukasi Multi Media Interaktif Dan Pendampingan Keluarga: Kontribusi Penting Kemampuan Keluarga Dalam Deteksi Dini Risiko Jatuh Pada Lansia Stroke** sesuai dengan waktunya

Penulisan monograf ini bertujuan memberikan pemahaman atau sebagai bahan referensi yang mendalam tentang peran media dan keluarga dalam deteksi dini risiko jatuh pada lansia, bisa juga dipergunakan sebagai bahan dalam pembelajaran dikelas atau lapangan serta bisa juga dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian,

Adapun kegiatan penulisan monograf ini mengacu pada kegiatan penelitian yang telah dilakukan di wilayah Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur. Isi dari pembahasan dalam monograf ini ada terbagi 3 bagian , bagian pertama adalah berupa pendahuluan, bagian kedua adalah bagian pokok pembahasan yang berisikan tentang konsep edukasi kesehatan yang berisikan apa itu edukasi kesehatan dengan multi media dan, dibahas juga tentang lanjut usia risiko jatuh karena stroke yang membahas konsep lansia konsep jatuh pada lansia dan penyakit yang dapat menimbulkan risiko jatuh yaitu stroke dimulai dari pengertian, tanda dan gejala, dan bagaimana pencegahan dan penanganannya serta dan bagian ke tiga penutup berupa Pembahasan dan kesimpulan

Pada kesempatan yang baik ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada team yang telah bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan penyusunan monograf dan kepada Informa yang memberi kesempatan untuk membuat karya yang bisa dipublikasikan

Akhir kata Penulis berharap semoga monograf ini memiliki peran penting dalam membantu pembaca memahami konteks pencegahan risiko jatuh pada lansia dan juga memberikan informasi yang berguna bagi khalayak umum dalam melakukan pencegahan jatuh dan pendampingan pada lansia. Penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penulisan monograf ini. Semoga monograf ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

November, 2024

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>PRAKATA.....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b> | <b>v</b>   |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b> | <b>1</b> |
|-------------------------------|----------|

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 2 EDUKASI KESEHATAN DENGAN MULTI MEDIA INTERAKTIF .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>A. Konsep Edukasi Kesehatan .....</b>                           | <b>9</b>  |
| 1. Pengertian Edukasi Kesehatan .....                              | 9         |
| 2. Tujuan Edukasi Kesehatan .....                                  | 10        |
| 3. Prinsip Edukasi Kesehatan .....                                 | 11        |
| <b>B. Multi Media Interaktif.....</b>                              | <b>12</b> |
| 1. Pengertian Multimedia interaktif .....                          | 13        |
| 2. Tujuan multimedia interaktif .....                              | 14        |
| 3. Fungsi Multimedia interaktif.....                               | 14        |
| 4. Jenis Multimedia .....                                          | 15        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 3 LANJUT USIA DAN RISIKO JATUH KARENA STROKE.....</b> | <b>19</b> |
| <b>A. Konsep Lansia .....</b>                                | <b>19</b> |
| 1. Pengertian Lansia.....                                    | 19        |
| 2. Perubahan Fungsional akibat Menua.....                    | 21        |
| <b>B. Konsep Jatuh.....</b>                                  | <b>23</b> |
| 1. Pengertian .....                                          | 23        |
| 2. Penyebab Jatuh .....                                      | 24        |
| 3. Deteksi Dini Risiko Jatuh .....                           | 24        |
| 4. Pencegahan Jatuh.....                                     | 26        |
| <b>C. Konsep Penyakit Stroke .....</b>                       | <b>28</b> |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Definisi Stroke Stroke .....            | 28 |
| 2. Klasifikasi / penggolongan stroke ..... | 29 |

## **BAB 4 PENDAMPINGAN KELUARGA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBERDAYAAN KELUARGA PADA KLIEN RISIKO JATUH KARENA STROKE ..... 37**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Konsep Pendampingan Keluarga.....</b> | <b>37</b> |
| 1. Pengertian Pendamping .....              | 37        |
| 2. Tugas Pokok Pendamping:.....             | 38        |
| 3. Peran Pendamping .....                   | 38        |
| 4. Fungsi Pendamping .....                  | 40        |
| 5. Prinsip Pendamping.....                  | 40        |
| 6. Evaluasi .....                           | 40        |
| 7. Kontinuasi atau Terminasi .....          | 41        |
| 8. Kegiatan Pendampingan.....               | 42        |
| 9. Pemberdayaan Keluarga .....              | 47        |

## **BAB 5 PENUTUP ..... 51**

## **DAFTAR PUSTAKA..... 53**

## **GLOSARIUM ..... 59**

## **PROFIL PENULIS ..... 61**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang memasuki fase *ageing population*, yaitu proporsi penduduk lanjut usia (lansia) semakin meningkat. Peningkatan ini menyebabkan meningkatnya umur harapan hidup dengan perubahan-perubahan yang dialami lansia baik dari aspek fisik, psikologis, sosial dan spiritual (Wirahardja & Satya, 2014). perubahan yang paling terlihat adalah kemunduran dan penurunan fisik, seperti penurunan massa dan kekuatan otot, melemahnya koordinasi motorik, dan hilangnya kemampuan bergerak dan mempertahankan keseimbangan yang dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari dan dapat menyebabkan terjadinya risiko jatuh (Mauk 2021). Jatuh pada lanjut usia (lansia) dapat mengakibatkan trauma baik fisik maupun psikologis bahkan kematian. Upaya untuk mencegah dan mengatasi jatuh pada lansia yang tinggal di rumah dapat menggunakan multimedia interaktif dan pendampingan keluarga, kegiatan ini diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Jatuh merupakan suatu kejadian fisik yang sering dialami lansia saat proses penuaan, dapat meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, kecacatan, gangguan fungsi sosial, dan penurunan kualitas hidup, hal ini karena jatuh menimbulkan trauma baik fisik maupun psikologis pada lansia, bahkan kematian, Jatuh pada lansia dapat juga disebabkan karena penyakit hipertensi yang menyebabkan stroke sebagai dampak dari gaya hidup. Situasi ini diperlukan dukungan keluarga

Dukungan keluarga menurut Friedman (2010) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota



keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. Dukungan keluarga merupakan peran serta atau partisipasi keluarga baik dalam bentuk sikap atau perilaku dalam memberikan semangat pada anggota keluarganya khususnya lansia yang bersifat fisik atau emosional seperti melakukan komunikasi untuk memberikan informasi, melakukan observasi atau pengamatan terhadap sikap dan perilaku lansia, memberikan dukungan emosional dengan menerima keberadaan lansia apa adanya dan selalu memberikan semangat atau spirit. Sehingga lansia merasa ada yang memperhatikan. Hal ini merupakan suatu bentuk terapi bagi lansia yang akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi dirinya

Hasil penelitian Rahayu dan Isnaeni tahun 2016 memperkuat pentingnya dukungan keluarga terhadap lansia dengan yang menyatakan bahwa “terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan resiko jatuh dirumah pada lansia”

Penelitian Aan Nurhasanah yang berjudul “Pengaruh Edukasi Multi Media Interaktif Dan Pendampingan Keluarga Terhadap Kemampuan Keluarga Dalam Deteksi Dini Risiko Jatuh Pada Lansia”, dengan rumusan masalahnya Bagaimana Pengaruh Bentuk Edukasi ( Multimedia ) Dan Pendampingan Keluarga Terhadap Kemampuan Keluarga Dalam Deteksi Dini Risiko Jatuh Pada Lansia ? mempunyai tujuan Mendapatkan gambaran tentang Pengaruh Bentuk Edukasi ( Multimedia ) Dan Pendampingan Keluarga Terhadap Kemampuan Keluarga Dalam Deteksi Dini Risiko Jatuh Pada Lansia menggunakan peneltisaan kuantitatif.*Design* penelitian yang digunakan

adalah quasi eksperimental dengan rancangan *pre-post test witht control* dengan intervensi edukasi kesehatan melalui kegiatan ceramah dengan menggunakan Multimedia Interaktif dan Pendampingan dengan sampel sebanyak 60 orang keluarga dengan lansia,dengan rincian 30 orang sebagai kelompok kontrol dan 30 orang kelompok eksperimen yang dipilih secara purposif sampling dan memenuhi kriteria inklusi yaitu keluarga dengan lansia yang ber riwayat penyakit hipertensi, stroke, bersedia jadi responden, mampu membaca dan menulis dan eksklusi adalah keluarga yang tidak mempunya lansia dengan riwayat hipertensi atau stroke dan tidak bersedia jadi responden, Data dikumpulkan dengan kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup. dan dianalisis dengan menggunakan *univariate, bivariate* (uji t test), dan multivatriate dengan analisis *Mancova*,

Hasilnya Berdasarkan karakteristik pendidikan, responden control dan responden perlakuan mempunyai kesamaan yaitu berlatar belakang SMA, menurut peneliti, artinya responden dengan tingkat pendidikan ini mudah menerima informasi yang berhubungan erat dengan pencarian ilmu pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk berperilaku dalam melakukan pendampingan pada lansia dalam upaya melakukan deteksi dini pencegahan risiko jatuh. Sehingga apabila mendapat permasalahan dengan lansia seperti jatuh mampu mengambil tindakan yang tepat. Faktor pendidikan merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi keluarga dalam berperilaku. Perilaku merupakan faktor terbesar kedua dalam mempengaruhi status kesehatan (Soekidjo; 2012). menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan jatuh pada lansia adalah dengan dilakukannya edukasi atau pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk mengingatkan pasien dan keluarga tentang bahayanya jatuh pada lansia.

Multi media interaktif dalam kegiatan pendidikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir lebih logis karena dilakukan secara interaktif.

Hasil penelitian dalam aspek pendampingan menunjukkan bahwa pendampingan pada lansia dengan risiko jatuh akibat stroke sangat penting untuk pencegahan risiko jatuh, hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nurmita Wijayakusuma (2015) menyatakan pendampingan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keberfungsian social. lansia mengalami penurunan fungsi tubuh. Baik yang bersifat fisiologis dan biokimia, sehingga akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan secara keseluruhan yang menyebabkan lansia perlu pendamping.

Intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberian edukasi menggunakan multi media interaktif selama 3x pertemuan dengan materi Kejadian jatuh pada lansia, dan tugas keluarga dalam pencegahan jatuh pada lansia, dilanjutkan dengan praktek latihan ROM (*Range Of Motion*) dan pendampingan untuk mendeteksi dini risiko jatuh pada lansia. Pemberian edukasi dilakukan menggunakan PPT, modul dan video secara zoom. Hal ini sesuai dengan informasi di negara luar telah melakukan pengembangan media pendidikan kesehatan yang ditransformasi kedalam kemanfaatan fitur *smartphone* digunakan dalam pendidikan kesehatan pada pasien, manajemen diri pada penyakitnya, dan pemantauan jarak jauh dari pasien, Pemanfaatan *smartphone* sebagai alat medis dapat berguna dalam praktek kedokteran yang (Mosa, Yoo, & Sheets, 2012).Juga Menurut Mosa et, al (2012 ) mengungkapkan bahwa penggunaan *smartphone* dalam pemberian informasi berupa pendidikan kesehatan pada keluarga dapat meningkatkan kemampuannya dalam manajemen diri secara mandiri diperkuat juga dari hasil

Penelitian yang dilakukan oleh Kim, Shin, Lee, Kang, & Bartlett, (2017) yang menyatakan bahwa bahwa pendidikan berbasis teknologi dapat menjadi metode yang efektif untuk digunakan dalam pendidikan keperawatan. Menurut Onono et all ,2014 bahwa Pemberian informasi kesehatan yang dirancang dengan baik sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dapat merubah proses pikir yang dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran yang telah diterima dari pendidikan kesehatan. Hal ini menurut peneliti akan berdampak pada perubahan perilaku untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

Peran promosi kesehatan sangat penting pada keluarga dengan lansia yang mengalami jatuh yang disebabkan karena dampak dari stroke atau pun factor lainnya, hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan semangat hidup dan dapat beraktifitas memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui kegiatan pemberdayaan. Keluarga berperan penting dalam pemberdayaan lansia yang berisiko jatuh, di antaranya dengan: melakukan pencegahan seperti memberikan edukasi menciptakan lingkungan yang aman, Memberikan dukungan dan pertolongan, Membantu lansia merawat diri, menjaga pola hidup sehat, seperti konsumsi makanan sehat ; buah dan sayur, makanan rendah lemak jenuh, lemak trans dan kolesterol, Membatasi garam (natrium) dalam makanan, melakukan aktifitas olah raga secara teratur, menghindari asap rokok, mengelola stress, . Edukasi kemungkinan terjadi stroke berulang dan cek kesehatan secara rutin serta melakukan terapi rehabilitasi medis teratur Membantu lansia menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis.

Tehnologi zaman sekarang khususnya di bidang multi media sudah semakain berkembang. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media (*Format file*) yang berupa teks,gambar suara, vidio dan animasi yang dikemas dalam *file*

*digital* . Multimedia interaktif sebagai salah satu media yang menarik karena merupakan gabungan antara gambar animasi bahkan suara sehingga penyuluhan kesehatan menjadi lebih menarik. Penelitian Novitasari (2016) membuktikan bahwa multimedia interaktif berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman terhadap suatu konsep yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Sadiman, dkk (2010) bahwa media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan dapat membantu mengatasi kesalahan dalam penafsiran. Kemampuan dalam pemahaman sangat penting karena dapat dilakukan suatu intervensi sesuai yang diharapkan dalam rangka upaya promosi dan preventif. Upaya promotif dan preventif ini memegang peran yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi kejadian jatuh pada lansia.

Hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan preventif atau pencegahan adalah melalui kegiatan deteksi dini salah satunya adalah penyakit yang sering diderita lansia seperti hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang meningkatkan risiko terjadinya jatuh pada lansia (Gangavati et al., 2011). Kondisi lansia seperti di atas membutuhkan bantuan pelayanan social dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-harinya hal ini karena sering menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, Pelayanan yang dibutuhkan lansia salah satunya adalah pendampingan. Pendampingan sebenarnya bisa dilakukan oleh keluarganya, akan tetapi karena tuntutan banyak, maka keluarga banyak yang melakukan aktifitas di luar seperti bekerja sehingga pendampingan digantikan oleh pendamping lansia di lembaga sosial atau panti werdha. Fenomena yang dihadapi saat ini di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan lansia di dalam pendampingan, sehingga perlu adanya kerjasama dengan keluarga untuk memenuhi

kebutuhan lansia tersebut melalui Home care. Program *Home care* bagi lansia merupakan pelayanan yang lengkap dan berguna serta sangat mendukung pemerintah dalam pelayanan terhadap lansia yang belum mendapat pelayanan kesejahteraan sosialnya dari model pelayanan yang lain. Pelayanan Home care ditujukan bagi lansia yang tidak potensial (tidak mampu) dan potensial (mampu) yang berada di lingkungan keluarga maupun lansia yang telah hidup sendiri. Bentuk kegiatan pelayanan *home care* berupa pemberian bantuan pangan, bantuan kebersihan, perawatan kesehatan, pendampingan, konseling, dan rujukan dengan melibatkan anggota keluarga dan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal lansia. Tujuan dari Home care adalah untuk membantu keluarga yang mempunyai lansia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan perawatan lansia yang belum terjangkau pelayanan



# BAB 2

## EDUKASI KESEHATAN DENGAN MULTI MEDIA INTERAKTIF

### A. Konsep Edukasi Kesehatan

---

#### 1. Pengertian Edukasi Kesehatan

Edukasi atau pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok/keluarga maupun masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pendidikan.

Pendidikan Kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Dilihat dari segi pendidikan, maka pendidikan kesehatan merupakan upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, keluarga/kelompok maupun masyarakat sehingga berperilaku sesuai apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo. 2017).

Edukasi kesehatan merupakan program kesehatan yang memegang peranan penting dalam menjaga dan memelihara serta meningkatkan kesehatan yang dirancang untuk mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat, sehingga berfikir, bersikap, dan berperilaku positif dalam rangka memelihara, meningkatkan kesehatan diri dan lingkungan.

Edukasi kesehatan merupakan salah satu kegiatan pemberian informasi dengan berbagai metode sebagai upaya memberikan pengetahuan bertujuan



untuk mengembangkan perilaku individu, keluarga atau kelompok, dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, sosial dan spiritualnya agar bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, dan terhindar dari penyakit yang datang dari dalam diri maupun luar dirinya sehingga produktif secara ekonomi maupun secara social. Melalui pemberian edukasi kesehatan diharapkan pengetahuannya bertambah sehingga kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatan baik yang bersifat individu, keluarga atau kelompok dan masyarakat tercipta.

## **2. Tujuan Edukasi Kesehatan**

Tujuan edukasi atau Pendidikan kesehatan menurut undang-undang kesehatan no 23 tahun 1992 maupun WHO adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun secara sosial.

Tujuan dari edukasi kesehatan secara umum adalah untuk mengembangkan perilaku individu, keluarga atau kelompok, dan masyarakat agar bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, dan terhindar dari penyakit yang datang dari dalam diri maupun luar dirinya

Secara garis besar, dari adanya kegiatan edukasi kesehatan diharapkan

- a. Adanya perubahan perilaku yang lebih sehat
- b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan cara hidup sehat dan menjaga lingkungan

- c. Terjadi peningkatan kesehatan baik fisik mental, sosial maupun spiritual
- d. Membantu masyarakat berperan serta aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat
- e. Menciptakan manusia yang produktif secara ekonomi dan sosial
- f. Menurunkan angka kesakitan dan kematian
- g. Memberikan peluang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri individu

Pemberian pendidikan atau edukasi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan dan memberikan informasi baik langsung maupun tidak langsung, instruksi atau peningkatan pemahaman terkait kesehatan. Pemberian edukasi kesehatan perlu memperhatikan prinsip:

### **3. Prinsip Edukasi Kesehatan**

- a. Belajar Mengajar berfokus pada klien, artinya pendidikan klien
- b. adalah hubungan klien yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik
- c. Belajar mengajar bersifat menyeluruh
- d. Belajar mengajar negosiasi

Pentingnya edukasi kesehatan adalah, agar masyarakat memiliki mutu kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya, dan terhindari dari resiko salah satunya jatuh. Mengingat dengan semakin berkembangnya teknologi maka proses pemberian edukasi juga mengalami peningkatan dengan memanfaatkan teknologi multimedia interaktif untuk penyampaian informasi agar mampu mengubah, menumbuhkan atau mengembangkan perilaku positif (Maulana, 2009)

## **B. Multi Media Interaktif**

---

Multimedia interaktif merupakan suatu media yang dipergunakan dalam proses kegiatan dirancang disesuaikan untuk memenuhi fungsi dalam menginformasikan pesan dan memiliki kemampuan interaktif dengan penggunaanya.

Multimedia merupakan suatu sistem karena multimedia merupakan teknologi yang menggabungkan berbagai sumber media seperti teks, grafik, suara, animasi, video yang disampaikan dan dikontrol sistem komputer secara interaktif. Multimedia pembelajaran memanfaatkan fleksibilitas komputer untuk memecahkan masalah-masalah belajar. Sebagaimana kebanyakan sistem mengajar, komputer dapat digunakan sebagai alat mengajar terutama untuk memberi penguatan, belajar awal, merangsang dan memotivasi belajar, atau untuk berbagai jenis kemungkinan lainnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari fleksibilitas komputer karena dapat memasukkan video, audio, elemen-elemen grafis. Berbagai model Computer Based Instructions yang dapat diterapkan antara lain model tutorial, drill and practice, simulasi, games

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa sehingga akan membantu keefektifan proses pembelajaran dalam penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan memadatkan informasi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan IPTEK semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa sehingga akan membantu keefektifan proses pembelajaran dalam penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan memadatkan informasi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan IPTEK semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Penggunaan multimedia menyebabkan pesan dapat ditampilkan melalui komputer sehingga user dapat melihat, mendengar, dan saling berinteraksi dan mengontrol media tersebut.

### **1. Pengertian Multimedia interaktif**

Multimedia interaktif adalah media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia interaktif

dapat memadukan berbagai unsur seperti teks, suara, animasi, video, dan gambar.

Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi dan suara. Untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi, melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Menurut Robin dan Linda (yang dikutip Benardo, 2011) Multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan persentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video. Sedangkan menurut. Menurut Hofstetter (seperti dikutip Benardo, 2011)

Multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berintraksi, berkreasi dan berkomunikasi

Elemen atau tehnologi utama dalam multi media interaktif ada 5 (lima) yaitu Teks, Ada lima Elemen atau teknologi utama dalam multimedia interaktif yaitu, Teks, *grafik, audio, video dan animasi*

## **2. Tujuan multimedia interaktif**

Tujuan dari mulrimedia interaktif adalah sebagai sarana dalam proses komunikasi non verbal yang menggunakan media elektronik seperti kompuer dan perangkat elektronik lain

## **3. Fungsi Multimedia interaktif**

Fungsi dari multimedia interaktif ada beberapa, yaitu:

- a. Fungsi Pembelajaran, yaitu memfasilitasi guru atau dosen atau pemateri dalam melakukan kegiatan

proses belajar mengajar sehingga menimbulkan minat dan ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran

b. Komunikasi

Sebagai sarana prasarana dalam kegiatan berkomunikasi bisnis baik dengan kompetitor, pelanggan ataupun birokrasi juga komunikasi kebudayaan.

c. Penyajian informasi

Kemampuan yang lebih detail dan efektif dalam menyajikan informasi.

d. Efisiensi waktu

Penggunaan waktu menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mempercepat aksi navigasi terhadap informasi yang dibutuhkan

e. Hemat biaya

Biaya menjadi lebih hemat.

f. Interaksi yang menyenangkan

Tidak menimbulkan kebosanan malah sebaliknya membuat senang dan bahagia

Multimedia interaktif dapat juga menciptakan pengalaman yang interaktif, menarik, dan menyenangkan bagi pengguna.

#### 4. Jenis Multimedia

Ada 3 jenis media pembelajaran interaktif yang dapat dengan mudah ditemukan di internet, yakni:

- a. Multimedia pembelajaran interaktif berbasis e-learning
- b. Media pembelajaran *websites* pendidikan situs belajar *on line*
- c. Media interaktif berbasis *software* dan media belajar interaktif berbasis aplikasi android

Menurut Azhar Arsyad (2011:29) media pembelajaran dikelompokkan menjadi beberapa nama yang didasarkan kepada perkembangan teknologinya yaitu:

- 1) Media hasil teknologi cetak. Merupakan teknologi cetak yang berfungsi untuk menghasilkan atau menyampaikan materi visual statis terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto atau representasi fotografik dan reproduksi.
- 2) Teknologi Audio Visual adalah salah satu cara dalam menghasilkan atau menyampaikan menggunakan sarana mesin mekanis dan elektronik untuk menyampaikan pesan secara audio visual. Pengajaran melalui audio visual adalah proses pembelajaran yang menggunakan indera mata dan penglihatan untuk mendapatkan pengertian atau pemahaman dari suatu objek yang dipelajari.
- 3) Teknologi Berbasis Komputer adalah strategi untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang menggunakan alat bantu teknologi berupa sumber-sumber yang mikro-prosesor. Teknologi berbeda dengan teknologi yang telah dijelaskan di atas, karena pada teknologi ini data atau informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital bukan dalam bentuk cetak atau visual belaka.
- 4) Teknologi Gabungan adalah penggunaan beberapa bentuk media untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yang dikendalikan oleh komputer. Penggunaan teknologi ini dianggap paling canggih karena memiliki kemampuan yang hebat

apabila di kendalikan dengan penggunaan perpaduan jenis teknologi computer yang memiliki jumlah random access memory ( RAM yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan alat-alat tambahan seperti videodisk player, perangkat keras bergabung dalam satu jaringan dan sistem audio.





# BAB 3

## LANJUT USIA DAN RISIKO JATUH KARENA STROKE

### A. Konsep Lansia

---

#### 1. Pengertian Lansia

Menurut Hidayat, usia lanjut atau lanjut usia adalah hal yang harus diterima sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. Kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian (Supraba, 2015). Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan- tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit seperti yang menyerang sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia, maka akan terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ yang tidak dapat dihindari.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, yang dimaksud lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita. Lansia adalah kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade (Notoadmojo, 2010). Penuaan merupakan proses normal perubahan yang berhubungan dengan waktu, sudah dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Lansia

adalah fase akhir dari rentang kehidupan (Fatimah, 2010). dasar dari proses menua adalah kegagalan fungsi homeostatik penyesuaian diri terhadap faktor intrinsik dan ekstrinsik. Menua adalah proses yang mengubah seorang dewasa sehat menjadi seorang yang rapuh dengan berkurangnya sebagian besar cadangan sistem fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit seiring dengan bertambahnya usia. Terjadi berbagai perubahan fisiologis yang tidak hanya berpengaruh terhadap penampilan fisik, namun juga terhadap fungsi dan tanggapan pada kehidupan sehari-har. Menua merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan terus menerus dan berkesinambungan. Proses penuaan akan menimbulkan berbagai perubahan anatomis, fisiologis dan biokimia pada tubuh, sehingga dampak yang terjadi dengan adanya perubahan tersebut adalah berpengaruh secara fisik, psikis, sosio ekonomi, sehingga secara umum akan berpengaruh pada *activity of daily living* (Fatmah, 2010). Kemunduran kemampuan dalam hal seperti fisik contoh gangguan penglihatan dan pendengaran akan mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan dalam beraktivitas sehingga dapat menimbulkan kejadian jatuh. Oleh karena itu lanjut usia membutuhkan alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Seiring bertambahnya usia maka imunitas menjadi menurun, pada lansia. Kekebalan terhadap penyakit akan menurun sehingga lansia rentan terhadap penyakit. Penyakit yang dialami lansia akan berpengaruh pada kesehatannya, sehingga lansia membatasi aktivitasnya, mengalami gangguan mobilisasi dan akibatnya berisiko jatuh. Resiko adalah

suatu kondisi bahaya atau konsekuensi yang dapat memprediksi terhadap kemungkinan terjadinya penyakit atau injuri pada individu atau kelompok akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang yang diakibatkan oleh lingkungan. Jatuh merupakan suatu kejadian fisik yang sering dialami oleh lansia saat proses penuaan. Peristiwa jatuh pada usia lanjut dapat menjadi penyebab meningkatnya angka morbiditas, angka mortalitas, kecacatan, gangguan fungsi sosial, dan penurunan kualitas hidup (Lowlar et al.,2003).

## **2. Perubahan Fungsional akibat Menua**

Perubahan fungsional akibat proses menua terjadi secara fisiologis maupun psikologis, seperti perubahan pada fungsi sensoris, neurologis, dan muskuluskeletal.

Perubahan pada fungsi sensoris meliputi menurunnya fungsi panca indera seperti pada penglihatan, terjadi perubahan penglihatan dan fungsi mata yang dianggap normal; seperti penurunan kemampuan untuk melakukan akomodasi, kontriksi pupil akibat penuaan dan perubahan warna serta kekeruhan lensa mata (katarak). Akibat perubahan ini dapat menimbulkan resiko kejadian jatuh. Perubahan penglihatan mempengaruhi dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari.

Penurunan pada aspek pendengaran dapat berupa pa perubahan dalam persepsi pendengaran adanya suara berdenging ditelinga (tinnitus), nyeri pada satu atau kedua telinga, perubahan kemampuan untuk mendengar suara frekuensi tinggi, menarik diri, ansietas, respons tidak sesuai dalam percakapan dan bukti- bukti klinis tentang pendengaran.

Perubahan pada aspek Perabaan menyebabkan lanjut usia tidak sensitive terhadap sentuhan. Perubahan

pada aspek Pengecapan lidah menyebabkan kepekaan terhadap rasa menurun dengan akibat berkurangnya nafsu makan dan bertambahnya kecenderungan lanjut usia untuk menambah bumbu seperti garam, gula, dan lain-lain pada makanannya.

Perubahan pada aspek Penciuman dapat mengurangi pula nafsu dan selera makan para lanjut usia.

Perubahan normal muskuluskeletal terkait usia pada lansia termasuk penurunan tinggi badan, redistribusi massa otot dan lemak sub cutan, peningkatan porositas tulang, atrofi otot, pergerakan yang lambat, pengurangan kekuatan dan kekakuan sendi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan penampilan, kelemahan dan lambanya pergerakan (Mickey, Stanley, 2007). Pendapat yang sama dikemukakan Maryam, 2008) yang mengatakan bahwa Perubahan pada sistem muskuloskeletal meliputi: tulang kehilangan densitas (cairan) dan semakin rapuh, kekuatan dan stabilitas tulang menurun, terjadi kifosis, gangguan gaya berjalan, tendon mengerut dan mengalami sklerosis, atrofi serabut otot, serabut otot mengecil sehingga gerakan menjadi lamban, otot kram, dan menjadi tremor, aliran darah ke otot berkurang sejalan dengan proses menua (Maryam, 2008). Semua perubahan tersebut dapat mengakibatkan kelambatan dalam gerak, langkah kaki menjadi pendek, dan adanya gangguan dalam berjalan. Kaki yang tidak dapat menapak dengan kuat akan lebih mudah goyah, lansia lambat mengantisipasi bila terjadi gangguan terpeleset, tersandung, mengalami gangguan keseimbangan sehingga mudah terjatuh. Gangguan keseimbangan merupakan penyebab utama yang sering mengakibatkan seorang lansia mudah jatuh.

## **B. Konsep Jatuh**

---

### **1. Pengertian**

Pasien jatuh merupakan kejadian pasien yang terjatuh ke lantai tanpa sengaja dengan atau tanpa adanya cedera setelahnya (Agency for Healthcare Research and Quality, 2013). Menurut American Nursing Association atau ANA (2009), pasien jatuh merupakan kondisi pasien terjatuh langsung ke lantai atau menimpa sesuatu (peralatan) di lantai yang terjadi tidak sengaja baik yang menimbulkan cedera atau tidak dan terjadi di ruang perawatan.

Sedangkan menurut pengertian yang lain, kejadian pasien jatuh adalah kejadian yang mengakibatkan pasien atau seseorang mendadak terbaring atau terduduk di lantai atau di tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan kesadaran (Darmojo, 2004 dalam Syahailatua, 2013).

Jatuh bisa merupakan salah satu ancaman bagi lansia yang disebabkan oleh multifaktor bisa berupa faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Menurut Darmojo (2012) resiko jatuh adalah suatu kejadian yang dilaporkan penderita atau keluarga yang melihat kejadian, yang mengakibatkan seseorang mendadak terbaring, terduduk di lantai atau tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kehilangan kesadaran atau luka.

Jatuh merupakan suatu kejadian yang menyebabkan subyek yang sadar menjadi berada di permukaan tanah tanpa disengaja. Dan tidak termasuk jatuh akibat pukulan keras, kehilangan kesadaran, atau kejang. Kejadian jatuh tersebut adalah dari penyebab yang spesifik yang jenis dan konsekuensinya berbeda dari mereka yang dalam keadaan sadar mengalami jatuh

(Stanley, 2006). Seiring bertambahnya usia, proses degenerasi anatomis dan fisiologis dalam tubuh meningkat. Degenerasi sistem muskuloskeletal yang terjadi pada lansia diantaranya penurunan kekuatan otot, serta keseimbangan tubuh yang berdampak 4 pada pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari serta resiko jatuh (Kusuma Wati et al., 2018).

## **2. Penyebab Jatuh**

Penyebab Jatuh pada lansia terbagi 2 yaitu

### **a. Faktor internal**

Menurut Kemenkes (2010) bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko jatuh pada lansia adalah faktor internal seperti penyakit yang diderita, gangguan penglihatan, gangguan adaptasi, gangguan kognitif, kardiovaskular seperti hipotensi postural atau sinkop, gelap, infeksi telinga, lemah otot tungkai, penyakit sistemik dan reaksi negatif obat-obat.

### **b. Faktor eksternal seperti akibat dari lingkungan, contohnyai kondisi tangga, lantai licin atau basah, pencahayaan yang kurang, toilet jauh dari kamar, kondisi terlalu rendah, sepatu yang buruk atau dengan sol licin, tempat tidur terlalu tinggi atau rendah, alat rumah tangga yang dapat menyebabkan jatuh seperti karpet, kaki kursi, dan kabel listrik**

## **3. Deteksi Dini Risiko Jatuh**

Faktor risiko jatuh pada lansia baik yang tinggal di komunitas maupun di Rumah Sakit atau dipanti mempunyai kesamaan yaitu bisa disebabkan karena faktor dari dalam diri lansia sendiri maupun dari luar diri lansia. contohnya gangguan keseimbangan atau gaya berjalan, mobilitas berubah, riwayat jatuh, bertambahnya usia, gangguan kemampuan berpikir, depresi,

pusing/vertigo, hipotensi ortostatik, gangguan penglihatan dan penggunaan obat penenang. Sehingga diperlukan deteksi dini.

Adapun tujuan deteksi dini adalah untuk memahami risiko jatuh, pencegahan dan perlindungan sehingga dapat dicegah atau diantisipasi dan meningkatkan kualitas hidup lansia dan kepuasan perawatan.

Metode deteksi dini yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi jatuh dilakukan dengan menggunakan penilaian risiko jatuh yaitu Skala *Hendrich Fall Scale (HFS)* dan *Morse Falls Scale (MFS)*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Armany Dessy, Harmayetty dan Yuni Widyawati yang berjudul Penilaian Risiko Jatuh Lanjut Usia (Lansia) Menggunakan Pendekatan Hendrich Falls Scale Dan Morse Falls Scale Itu menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrument MFS lebih sensitif dibandingkan HFS untuk menilai lansia dengan risiko jatuh karena item-item penilaian yang lebih rinci. Metode lain untuk penilaian risiko jatuh dapat dipergunakan kegiatan senam sesuai dengan penelitian dari Adi Praetyo dan Nandang dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keseimbangan Postural Menggunakan Pengukuran Berg Balance Scale (Bbs) Pada Lansia Di Sasana Panti Mulyo Sragen yang menyatakan bahwa Senam Sehat Indonesia dapat meningkatkan keseimbangan tubuh lansia di Sasana Panti Mulyo desa Cantel kabupaten Sragen. Metode lain yang dapat dipergunakan adalah dengan pengamatan pola jalan lansia, hal ini sesuai dengan penelitian Condrowati yang meneliti pola jalan lansia dengan judul Analisis Pola Jalan Lanjut Usia Terhadap Risiko Jatuh Di Posyandu Lansia



Wilaya Secara statistik lebar langkah yang signifikan mempengaruhi risiko jatuh. Panjang langkah tidak signifikan mempengaruhi risiko jatuh. Kecepatan berjalan tidak signifikan mempengaruhi risiko jatuh

#### **4. Pencegahan Jatuh**

Kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan jatuh meliputi:

- a. Pemeriksaan dini untuk mengetahui adanya faktor resiko jatuh dengan melakukan Pengkajian:
  - 1) keadaan sensorik,
  - 2) Sistem muskuluskeletal, dan
  - 3) Penyakit sisatemik yang sering menyebabkan keadaan jatuh
- b. Latihan Fisik.

Tujuan untu meningkatkan kekuatan tungkai dan tangan, memperbaiki keseimbangan, koordinasi, dan meningkatkan reaksi terhadap bahaya lingkungan.

Bentuk Latihan fisik yang dianjurkan adalah

  - 1) latihan fisik yang dapat melatih kekuatan tungkai, pergelangan,
  - 2) Dilakukan sesuai semampunya,
  - 3) Latihan berjalan kaki,
  - 4) Senam lansia, dan
  - 5) Latihan keseimbangan.
- c. Management Obat-Obatan
  - 1) Mengurangi penggunaan obat-obatan yang sifatnya untuk waktu lama missal: obat tidur
  - 2) Melakukan konsultasi terhadap penggunaan obat-obat yang harus dikonsumsi jangka panjang, missal: obat hipertensi, obat DM, dll.
  - 3) Gunakan alat bantu berjalan jika diperlukan.

d. Modifikasi Lingkungan

Beberapa Kegiatan yang dapat dilakukan seperti:

- 1) Pengaturan suhu ruangan
- 2) Penataan barang-barang yang sering diperlukan berada dalam jangkauan Lansia tidak harus berjalan terlalu jauh dari tempatnya,
- 3) Menggunakan karpet antislip dikamar mandi
- 4) Memasang pegangan tangan pada tempat yang diperlukan,
- 5) Memfasilitasi penerangan yang memadai,

e. Pengaturan dalam perubahan Sikap

- 1) Perubahan posisi, dari posisi duduk atau jongkok ke posisi berdiri dilakukan secara perlahan,
- 2) Posisi dalam pengangkatan benda/ barang yang berat sekaligus, dan atau melakukan pengangkatan benda/barang dengan cara posisi jongkok
- 3) Hindari aktifitas berolahraga yang berat dan berlebihan,
- 4) Hindari Pemakaian sepatu berhak tinggi, berjalan hanya dengan kaos kaki
- 5) Gunakan sepatu yang berhak rata dan lebar lebar dan datar, atau gunakan sepatu antislip dengan alas yang kasar.

f. Memelihara Fungsi Indera Penglihatan dan pendengaran  
Fungsi penglihatan dan pendengaran berpengaruh besar terhadap kejadian jatuh pada lansia karena sudah mengalami penurunan fungsi sehingga perlu memperhatikan pemeliharaan kesehatan fungsi mata dan pendengaran

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Alat bantu berupa kaca mata,

- 2) Alat bantu pendengaran, dan
- 3) Pencahayaan lingkungan

## **C. Konsep Penyakit Stroke**

---

### **1. Definisi Stroke Stroke**

Stroke adalah suatu penyakit defisit neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan cacat atau kematian (Munir, 2015). Menurut Kemenkes RI (2019) stroke merupakan manifestasi klinis akut akibat disfungsi neurologis pada otak, medulla spinalis, dan retina baik sebagian atau menyeluruh yang menetap selama sekitar 24 jam atau dapat menimbulkan kematian akibat adanya gangguan pada pembuluh darah. Sedangkan Stroke menurut WHO (*World Health Organization*) adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak baik fokal maupun global, dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih, dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain vaskuler (Munir, 2015).

Para ahli menyimpulkan stroke adalah suatu penyakit atau gangguan pada sistem neurologis yang terjadi akibat kurangnya suplai oksigen ke otak secara mendadak akibat adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah ke otak yang dapat menimbulkan cacat dan kematian.

Tanda dan Gejala. Secara umum penyakit stroke adalah munculnya sakit kepala yang hebat, afasia (bicara tidak lancar, ucapan kurang, atau sulit memahami ucapan), hemiparesis (kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh) dan facial palsy (kelemahan pada sebagian otot wajah), perubahan mendadak status mental (bingung,

mengigau, koma), disartria (bicara pelo atau cadel), gangguan penglihatan atau diplopia (penglihatan dubel) (Alifia, 2021).

## **2. Klasifikasi / penggolongan stroke**

Penyakit stroke dapat digolongkan menjadi 2 yaitu

### **a. Stroke Iskemik**

Stroke iskemik terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah di otak oleh kolesterol atau lemak lain sehingga suplai oksigen ke otak terhambat. Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi akibat kematian jaringan otak karena gangguan aliran darah ke daerah otak, yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri serebral atau servikal. Stroke iskemik secara umum diakibatkan oleh aterotrombosis pembuluh darah serebral, baik yang besar maupun yang kecil

Stroke iskemik yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Stroke iskemik secara umum diakibatkan oleh aterotrombosis pembuluh darah serebral, baik yang besar maupun yang kecil. Stroke iskemik juga dikenal dengan sebutan stroke infark. Darah ke otak disuplai oleh dua arteri karotis interna dan dua arteri vertebralis. Arteri-arteri ini merupakan cabang dari lengkung aorta jantung. Suatu ateroma (endapan lemak) bisa terbentuk di dalam pembuluh darah arteri karotis sehingga menyebabkan berkurangnya aliran darah. Keadaan ini sangat serius karena setiap pembuluh darah arteri karotis dalam keadaan normal memberikan darah ke sebagian besar otak. Endapan lemak juga bisa terlepas dari dinding arteri dan mengalir di dalam darah

kemudian menyumbat arteri yang lebih kecil. (Yueniwati, 2016)

1) Stroke iskemik menurut Alifia, 2021, terdiri dari 3 jenis yaitu:

- a) Stroke Trombotik Yaitu jenis stroke yang disebabkan terbentuknya thrombus yang menyebabkan terjadinya penggumpalan.
- b) Stroke Embolik Yaitu jenis stroke yang disebabkan oleh karena tertutupnya pembuluh arteri oleh bekuan darah.
- c) Hipoperfusi Sistemik Yaitu jenis stroke yang disebabkan berkurangnya aliran darah ke seluruh bagian tubuh karena adanya gangguan denyut jantung.

2) Tanda dan gejala stroke iskemik;

Pada stroke iskemik, ditandai dengan disfagia (kesulitan menelan), kebutaan monokuler (kehilangan penglihatan sementara dan pada satu mata), afasia/gangguan bahasa, gangguan sensorik dan motorik, hilangnya kesadaran, dan dapat mengganggu fungsi serebelar, nyeri kepala, tekanan darah meningkat, muntah, kejang, lesu, penurunan kesadaran, bradikardi, kaku leher, kelumpuhan, kelumpuhan lapang pandang vertikal, penurunan kelopak mata dan pupil tidak reaktif (Alifia, 2021).

b. Stroke hemoragik

1) Definisi Stroke hemoragik

Stroke hemoragik adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di sekitar atau di dalam otak, sehingga suplai darah ke jaringan otak akan tersumbat. Akibat pecahnya pembuluh darah dapat membanjiri jaringan otak

yang ada disekitarnya, sehingga fungsi otak akan terganggu (Kanggeraldo, Sari, & Zul, 2018).

Stroke hemoragik merupakan stroke yang terjadi karena pecahnya pembuluh darah, sehingga mengakibatkan darah di otak mengalir ke rongga sekitar jaringan otak. Seseorang yang menderita stroke hemoragik akan mengalami penurunan kesadaran, karena kebutuhan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah ke otak tidak terpenuhi akibat pecahnya pembuluh darah (Ainy & Nurlaily, 2021).

Stroke Hemoragik adalah serangan terjadi pada otak yang mengalami kebocoran atau pecahnya pembuluh darah di dalam otak, sehingga darah menggenangi atau menutupi ruang-ruang jaringan sel otak. Adanya darah yang menggenangi dan menutupi jaringan sel otak, akan menyebabkan kerusakan jaringan sel otak dan ini menyebabkan kerusakan fungsi otak. Genangan darah bisa terjadi pada otak sekitar pembuluh darah yang pecah (intracerebral hemorage) atau dapat juga genangan darah masuk ke dalam ruang sekitar otak (subarachnoid hemorage). Dampak stroke Hemoragik sangat luas dan fatal, bahkan sampai kepada kematian (Wardhana, 2011).

## 2) Penyebab Terjadinya Stoke Hemoragik

Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak bocor atau pecah. Haryono dan Utami (2019) Stroke hemoragik (perdarahan otak) dapat disebabkan oleh banyak kondisi yang memengaruhi pembuluh darah, antara lain : a). Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol (hipertensi) b).

Overtreatment dengan antikoagulan (pengencer darah) c). Melemahnya dinding pembuluh darah d). Penyebab yang kurang umum adalah pecahnya jalinan abnormal pembuluh darah berdinding tipis (malaformasi arteriovenosa).

Menurut Haryono dan Utami (2019), ada beberapa faktor risiko stroke yang berpotensi dapat diobati atau dimodifikasi, yaitu antara lain:

- a) Faktor risiko gaya hidup
  - (1) Kelebihan berat badan atau obesitas
  - (2) Ketidakaktifan fisik
  - (3) Minuman berat atau pesta
  - (4) Penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain dan metamfetamin
- b) Faktor risiko medis ;
  - (1) Memiliki tekanan darah lebih tinggi dari 120/80 mmHg
  - (2) Merokok. Kebiasaan merokok menjadi faktor risiko yang potensial terhadap terjadinya stroke akibat dari pecahnya pembuluh darah pada daerah posterior otak. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan nikotin pada rokok yang akan meningkatkan denyut 12 jantung dan tekanan darah, menurunkan kolesterol HDL baik dan jahat, serta mempercepat arteriosklerosis.
  - (3) Gaya hidup tidak sehat Hal ini berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi, seperti makanan tinggi lemak dan tinggi kolesterol. Kurangnya aktivitas fisik dan olahraga juga rentan menyebabkan terkena obesitas, diabetes, Hiperkolesterol adalah zat yang

berperan dalam terbentuknya arteriosklerosis di lapisan dalam pembuluh darah yang akan menyebabkan pembuluh darah menjadi tersumbat, terutama pembuluh darah di otak. Jika penyumbatan tersebut berhasil dan penyakit jantung,

- (4) Diabetes Risiko terkena stroke akan meningkat sebesar 2,3 kali lebih besar pada pria dan 3,8 kali lebih besar pada wanita yang menderita diabetes. Hal ini karena tingginya kadar gula akan mampu menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan mempercepat terjadinya arteriosklerosis pada arteri kecil termasuk pembuluh darah otak
  - (5) Apnea tidur obstruktif (gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur)
  - (6) Penyakit kardiovaskular, termasuk gagal jantung, cacat jantung, infeksi jantung atau irama jantung yang tidak normal
  - (7) Riwayat pribadi atau keluarga terkait stroke, serangan jantung.
- c) Faktor-faktor lain yang terkait dengan risiko stroke, termasuk:
- (1) Usia. Orang berusia 55 tahun atau lebih memiliki risiko stroke yang lebih tinggi daripada orang yang lebih muda.
  - (2) Ras. Orang Afrika-Amerika memiliki risiko stroke yang lebih tinggi daripada orang-orang dari ras lain.
  - (3) Jenis kelamin. Pria memiliki risiko stroke yang lebih tinggi daripada wanita.



Perempuan biasanya lebih tua ketika mereka mengalami stroke.

- (4) Hormon. Penggunaan pil KB atau terapi hormon yang termasuk estrogen, serta peningkatan kadar estrogen dari kehamilan dan persalinan.

### 3) Tanda dan Gejala Stroke Hemoragik

Gejala Stroke Hemoragik biasanya muncul tiba-tiba tanpa peringatan, dan sering selama aktivitas, sering muncul, menghilang, atau perlahan-lahan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu.

Gejala Stroke Hemoragik (Arief Mansjoer, 2016)

- a) Intraserebral hemoragik (ketika pembuluh darah di dalam otak pecah) :

gejala yang timbul; nyeri kepala yang hebat, sering terjadi pada seang hari, timbul mendadak setelah melakukan aktivitas dan emosi, pada awal permulaan serangan sering terjadi mual muntah, pusing, hemiparesis (ketidakmampuan untuk bergerak pada satu sisi tubuh), kesadaran menurun dan cepat terjadi koma (sekitar 65% terjadi kurang dari ½ jam, 23% terjadi antara ½ sampai dengan 2 jam, bisa sampai 12 hari).

- b) Subarachnoid hemoragik (ketika pembuluh darah di permukaan otak pecah dan bocor ke dalam ruang subaraknoid) gejala yang timbul yaitu; nyeri kepala hebat dan akut, kesadaran terganggu dan bervariasi, terjadi gejala atau tanda rangsangan meningeal, akan terjadi edema pada papil jika terdapat perdarahan.

Tanda Stroke Hemoragik menurut (Setiyawan, Nurlely, & Hatati, 2019) adalah:

- a) Sakit kepala hebat tiba-tiba
  - b) Kelemahan di lengan atau di kaki
  - c) Penurunan kesadaran
  - d) Kehilangan ketrampilan motorik (gerak) halus
  - e) Kehilangan keseimbangan tubuh, sedangkan  
sedangkan menurut Tarwotogejala stroke  
haemorhagik adalah
    - (1) Kejang tanpa riwayat kejang sebelumnya,
    - (2) mual atau muntah,
    - (3) Gangguan penglihatan,
    - (4) Kelumpuhan pada wajah atau separuh  
anggota tubuh (*hemipharse*) atau  
hemiplegia (*paralisis*) yang timbul secara  
mendadak,
    - (5) kesulitan dalam bicara (afasia),
    - (6) bicaranya cadel atau pelo (*disatria*) dan  
kesulitan menelan (*disfagia*) karena ada  
kerusakan pada *nervus cranial IX*,
    - (7) kehilanagn kesadaran,
    - (8) Vertigo, nyeri kepala terjadi karena ada  
peningkatan intra cranial dan edema cerebri
- Menurut pedoman praktik dari berbagai organisasi,  
pasien harus menjalani penilaian risiko jatuh  
setidaknya setahun sekali. Namun, dalam beberapa  
kasus, penyedia layanan kesehatan mungkin  
menyarankan pemeriksaan yang lebih sering  
terhadap ;
- a) Post Stroke
  - b) Usia lanjut.
  - c) Masalah keseimbanagn.

- d) Kesulitan berjalan ( gangguan gaya berjalan)
- e) Mudah terganggu ( gangguan kognitif ringan )
- f) Jantung berdebar
- g) Tekanan darah rendah ( hipotensi ) di saat berdiri.
- h) Gangguan penglihatan

# BAB 4

## PENDAMPINGAN KELUARGA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBERDAYAAN KELUARGA PADA KLIEN RISIKO JATUH KARENA STROKE

### A. Konsep Pendampingan Keluarga

---

#### 1. Pengertian Pendamping

Pendampingan menurut Depsos 2009 diartikan sebagai suatu proses interaksi dalam bentuk ikatan sosial antara pendamping dengan yang didampingi dalam upaya memberikan kemudahan (fasilitasi) kepada yang didampingi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi serta mendorong tumbuhnya keberanian untuk mengungkap realitas hidup dan melakukan aktivitas guna meningkatkan kualitas hidup mereka yang didampingi”.

Jadi pendampingan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam meningkatkan kemampuan lanjut usia sehingga mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya agar mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya dalam lingkungan masyarakat

Pendampingan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya serta penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lansia melalui partisipasi dan Dalam proses pendampingan

membutuhkan seorang pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan.

## **2. Tugas Pokok Pendamping:**

- a. Menyusun rencana, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan lanjut usia.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja terkait.
- c. Memperkuat fungsi keluarga.

## **3. Peran Pendamping**

Menurut Kemensos RI (2010:22) pendampingan diartikan sebagai proses interaksi dalam bentuk ikatan sosial antara pendamping dengan yang didampingi dalam upaya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi lanjut usia serta mengupayakan pemecahan permasalahannya.

Pendamping berperan dalam mengembangkan dan menindaklanjuti gagasan/ide yang muncul dari lanjut usia (Kementerian Sosial RI, 2010: 23). Peran pendamping diantaranya:

### **a. Pembela (*Advocator*)**

Pendamping berperan sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada lansia, memperlakukan dengan adil, bukan hanya sebagai pembela tetapi bagaimana mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku.

### **b. Memfasilitasi (*Fasilitator*)**

Pendamping berperan sebagai penghubung lanjut usia dengan sistem sumber yang ada di masyarakat, merujuk dan menindaklanjuti pelayanan, dan memberikan pertolongan kongkrit.

### **c. Pemungkin (*Enabler*)**

Pendamping mengidentifikasi permasalahan lanjut usia, kebutuhan, meluruskan permasalahan, menjajagi langkah-langkah menghadapi masalah lansia.

- d. Penjangkauan (*Outreacher*) Pendamping berperan menjangkau kelompok-kelompok

lanjut usia yang membutuhkan bantuan dan mencatat kondisi lingkungan yang menghambat akses lanjut usia.

- e. Pembimbing (*Supervisor*)

Pendamping berperan membimbing dan mendorong lanjut usia dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.

- f. Penggerak (*Dinamisor*)

Pendamping berperan menggerakkan, menciptakan peluang dan mencari sumber dana dan daya untuk mengembangkan pelayanan sosial bagi lanjut usia.

- g. Pemotivasi (*Motivator*)

Pendamping memberikan rangsangan dan dorongan

semangat kepada lanjut usia untuk dapat bersikap positif, pola pikir, dan mengembangkan potensi bagi peningkatan kesejahteraan sosial di masa tuanya.

- h. Katalisator Pendamping memberikan masukan-masukan dalam berbagai masalah yang dirasakan oleh lanjut usia dan mau mendengarkan keluhan-keluhan serta dapat membantu mencari alternatif pemecahan masalah yang dapat dipilih oleh lanjut usia.

- i. Mediator Pendamping berperan dalam menghubungkan dan memediasi lanjut usia dengan berbagai pihak termasuk sistem sumber, baik formal maupun informal.
- j. Elaborator

#### **4. Fungsi Pendamping**

- a. Sosialisasi/kampanye sosial tentang pelayanan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- b. Pendataan lansia.
- c. Menentukan skala prioritas kebutuhan lanjut usia.
- d. Membantu menyusun program kegiatan pelayanan lanjut usia.
- e. Menginformasikan dan mengkoordinasikan program kegiatan pelayanan sosial lanjut usia kepada mitra kerja terkait.
- f. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan.
- g. Menyusun rencana tindak lanjut.

#### **5. Prinsip Pendamping**

Menurut kemensos (2010) Ada beberapa prinsip pendampingan pelayanan sosial lanjut usia, yaitu

- a. Kemandirian, memberi kesempatan kepada lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya semaksimal mungkin.
- b. Hak asasi, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada lanjut usia untuk menentukan nasib sendiri, tidak ada paksaan.
- c. Menghormati adat-istiadat atau budaya masyarakat setempat.
- d. Menjaga kerahasiaan.
- e. Menjaga rasa aman

#### **6. Evaluasi**

Untuk dapat melihat segi keberhasilan kegiatan yang dilakukan perlu diadakan evaluasi

Evaluasi merupakan unsur yang cukup penting karena memungkinkan pendamping maupun unsur unsur yang terkait memberikan respon dan pertanggungjawaban sehingga dapat diketahui ampuh atau tepat tidak intervensi yang dilakukan.

## **7. Kontinuasi atau Terminasi**

Kontinuasi atau Terminasi merupakan indikasi kapan akibat suatu kegiatan bergerak atau diakhiri

Pada hal-hal yang diinginkan sehingga secara langsung memperkuat atau menegaskan validitas keaslian assesment, pendefinisian masalah, tujuan, penyeleksian model intervensi dan kontrak. Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan-permintaan lansia berhenti dan pendamping sudah tidak akan terlibat lebih lama lagi.

Pendampingan keluarga dalam pencegahan risiko jatuh pada lansia bisa dipantau dengan menggunakan Pedoman Observasi pendampingan keluarga oleh kader dalam pencegahan risiko jatuh pada lansia.

Pendampingan diperlukan karena Keluarga memegang peranan yang sangat penting untuk dapat mengembalikan kepercayaan lanjut usia agar merasa masih dibutuhkan dan mampu berdayaguna, baik di lingkungan keluarga maupun dalam hidup bermasyarakat, sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat masih banyak ditemukan keluarga lanjut



usia yang belum memahami kebutuhan lanjut usia, mengingat kebutuhan lanjut usia tidak sebatas tercukupi makan, minum, dan menjaga kesehatan fisik saja, tetapi juga diperlukan kepedulian keluarga didalam pemenuhan kebutuhan psiko-sosialnya. Hal ini diharapkan dapat memotivasi dan memfasilitasi Keluarga agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan keberfungsian sosial lanjut usia dengan berbagai masalah yang dialami lansia sehingga mampu meningkatkan status kesehatan lansia secara optimal.

## **8. Kegiatan Pendampingan**

Kegiatan Pendampingan dilakukan pada Kader Kesehatan dan Keluarga sebagai caregiver (pelaku rawat) utama yang merawat lansia di rumah.

Adapun strategi pendampingan yang dilakunan adalah sebagai berikut:

### **a. Persiapan**

- 1) Kader menghubungi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyepakati waktu pendampingan yang dilakukan 2 kali seminggu
- 2) Kader menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk keperluan mencatat masalah atau hambatan yang ditemukan yang akan dilaporkan kepada perawat

### **b. Pelaksanaan**

- 1) Kader mengunjungi rumah keluarga dengan membuat kontrak waktu kunjungan 2 kali seminggu
- 2) Kader menanyakan apa yang telah dilakukan keluarga dalam membantu mengatasi masalah lansia
- 3) Kader mengecek buku kerja keluarga yang telah

- diisi
- 4) Kader mencatat masalah atau hambatan yang ditemukan dalam melakukan pendampingan
  - 5) Kader melaporkan masalah atau hambatan kepada perawat untuk ditindaklanjuti
- c. Evaluasi
- 1) Kader melakukan penilaian terhadap kemampuan keluarga dalam merawat lansia dengan menanyakan respon lansia
  - 2) Kader mengobservasi kemampuan keluarga melalui komunikasi yang dilakukan keluarga dengan lansia serta kegiatan yang telah dilatih
  - 3) Kader mengecek kemampuan keluarga melakukan pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan melalui buku kerja keluarga
- d. Lembar Observasi Pendampingan Keluarga Kepada Lansia Dengan risiko jatuh.
- Petunjuk Pengisian: Berikan tanda (V) pada pernyataan yang sesuai dan tanda (X) apabila pernyataan tidak sesuai
- 1) Komunikasi keluarga pada lansia risiko Jatuh

**Tabel: 4.1: Komunikasi Keluarga  
Pada Lansia Risiko Jatuh**

| No | Aspek Yang Diobservasi                           | Jawaban |       |    |       |    |       |
|----|--------------------------------------------------|---------|-------|----|-------|----|-------|
|    |                                                  | Ya      | Tidak | Ya | Tidak | ya | tidak |
| 1  | Bersikap Hormat dan Sopan                        |         |       |    |       |    |       |
| 2  | Ada kontak mata saat berkomunikasi dengan lansia |         |       |    |       |    |       |
| 3  | Menggunakan Sentuhan lembut di                   |         |       |    |       |    |       |

|    |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|    | tangan, lengan,<br>atau pundak                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Membiarkan lansia berbicara beberapa menit tentang masalahnya tanpa interupsi                      |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Berbicara pelan, jelas, tanpa berteriak, menggunakan bahasa dan kalimat yang singkat dan sederhana |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Berbicara menggunakan bahasa dan kalimat yang singkat dan sederhana                                |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Memberikan waktu yang cukup kepada lansia untuk menjawab.                                          |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Menggunakan kata-kata /bahasa yang mudah dimengerti lansia                                         |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Menggunakan pertanyaan pendek dan jelas                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mendengarkan setiap pendapat yang disampaikan lansia                                               |  |  |  |  |  |  |

|    |                                          |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 11 | Menciptakan Lingkungan yang nyaman,      |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Menjaga agar tingkat kebisingan minimum. |  |  |  |  |  |  |

2) Keterampilan Keluarga Melakukan Deteksi Dini Risiko Jatuh

**Tabel: 4.2: Keterampilan Keluarga Melakukan Deteksi Dini Risiko Jatuh**

| No | Aspek Yang Diobservasi                                                                                   | Jawaban |       |    |       |    |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-------|----|-------|
|    |                                                                                                          | Ya      | Tidak | Ya | Tidak | ya | tidak |
| 1  | Mengenali setiap gejala fisik yang muncul terkait risiko jatuh lansia seperti pusing, kaku pada kaki dll |         |       |    |       |    |       |
| 2  | Mengenali setiap keluhan psikis yang terjadi pada lansia seperti sering marah, mudah tersinggung dll     |         |       |    |       |    |       |
| 3  | Mengenali penyebab lansia mengalami kesulitan tidur                                                      |         |       |    |       |    |       |
| 4  | Mendeteksi dini tekanan darah tinggi lansia, > 140 mm Hg                                                 |         |       |    |       |    |       |

|   |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Mendeteksi adanya faktor pencetus risiko jatuh lansia, seperti pusing, kurang tidur, gaya berjalan, keluhan pada daerah kaki, kurang olahraga, obat yang diminum |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mendeteksi komplikasi yang terjadi pada lansia akibat jatuh seperti tidak mampu bergerak, jalan tidak seimbang, kesemutan, dll                                   |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mendeteksi hal hal yang bisa menyebabkan stress lansia risiko jatuh (meminimalkan masalah keluarga dll)                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mencatat semua keluhan lansia risiko jatuh                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |

- 3) Keterampilan Keluarga Menyiapkan Diet, Obat Olahraga Dan Kebutuhan Aktifitas Sehari Hari (Activity Daily Living/Adl).

**Tabel 4.3: Keterampilan Keluarga Menyiapkan Diet, Obat Olahraga Dan Kebutuhan Aktifitas Sehari Hari (Activity Daily Living/Adl).**

| No                 | Aspek Yang Diobservasi                                       | Jawaban |       |    |       |    |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-------|----|-------|
| Tanggal observasi: |                                                              | Mandiri |       |    |       |    |       |
|                    |                                                              | Ya      | Tidak | Ya | Tidak | ya | tidak |
| 1                  | Menyiapkan Diet                                              |         |       |    |       |    |       |
| 2                  | Menyiapkan Obat                                              |         |       |    |       |    |       |
| 3                  | Olahraga                                                     |         |       |    |       |    |       |
| 4                  | Kebutuhan Aktifitas Sehari Hari (Activity Daily Living/Adl). |         |       |    |       |    |       |
| 5                  | Berjalan                                                     |         |       |    |       |    |       |
| 6                  | Aktifitas berpindah tempat menggunakan alat bantu            |         |       |    |       |    |       |

#### 4) Obsevasi Status Mental

**Tabel 4.4: Observasi Status Mental**

| No                 | Aspek Yang Diobservasi | Jawaban |       |    |       |    |       |
|--------------------|------------------------|---------|-------|----|-------|----|-------|
| Tanggal observasi: |                        | Ya      | Tidak | Ya | Tidak | ya | tidak |
| 1                  | Mudah lupa             |         |       |    |       |    |       |
| 2                  | Orientasi baik         |         |       |    |       |    |       |

## 9. Pemberdayaan Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena keluarga

Pemberdayaan keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah, baik kesehatan,

ekonomi, maupun sosial; Secara umum pemberdayaan keluarga dapat meliputi

a) Pemberdayaan ekonomi keluarga

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menciptakan lapangan kerja atau pemberian kemudahan perizinan untuk berusaha sehingga keluarga terbantu untuk melakukan kegiatan ekonomi, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja atau kemudahan berusaha.

b) Pemberdayaan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kegiatan yang dilakukan adalah Meningkatkan kemampuan dan kemandirian keluarga melalui proses pembelajaran, seperti pengelolaan keuangan, kesehatan, dan gizi.

c) Pemberdayaan keluarga desa

Memberikan dukungan dan bantuan agar keluarga desa dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. 4. Pemberdayaan keluarga dalam mengasuh anak

Kegiatan yang dilakuakn Meningkatkan kemampuan keluarga

dalam mengasuh dan menumbuhkembangkan anggota keluarga.

Pemberdayaan keluarga dalam melakukan pendampingan pada lansia dapat dilakukan dengan kegiatan, seperti:

1. Meningkatkan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan
2. Peningkatan kualitas remaja
3. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga
4. Peningkatan kapasitas dan sumber daya keluarga

Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses dari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemeliharaan dan perlindungan keluarga dengan proses memampukan keluarga agar dapat mengoptimalkan kemampuannya. Dalam mengasuh dan menumbuhkan kembangkan anggota keluarganya juga upaya dalam menurunkan ketidakharmonisan akibat dampak dari adanya masalah seperti jatuh akibat stroke, karena dampak dari terkena serangan stroke individu akan mengalami berbagai perubahan baik yang bersifat bio, psiko, sosial dan spiritualnya, penanganan yang cepat dan tepat sangat menentukan keberhasilan pemulihan pasien sehingga tidak mengalami ketergantungan total. Kesehatan merupakan asset yang perlu dijaga dan dilindungi juga ditingkatkan terus.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanganan penyembuhan pasien pada kasus pasca stroke agar terhindar dari jatuh dalam melakukan aktifitas sehari-hari adalah pemberdayaan keluarga dengan memberi dukungan penuh pada pemenuhan kebutuhan aktifitas sehari-hari lansia . Pemberdayaan keluarga pada prinsipnya memampukann keluarga sendiri berdasarkan potensi yang ada dalam diri keluarga, mengembangkan partisipasi atau gotong ryong dalam keluarga, menggali kontribusi keluarga juga menjalin kemitraan.

Kemandirian keluarga di bidang kesehatan sebagai bentuk wujud pemberdayaan dari tanggung jawab agar hak-hak lansia dapat terpenuhi. Dukungan keluarga menurut Friedman (2010) adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental



dan dukungan emosional. Jadi dukungan keluarga adalah suatu bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa ada yang memperhatikan. Handayani mengutip pernyataan Friedmen menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu bentuk dari terapi keluarga yang sangat berharga karena dapat menjadikan lansia merasa tentram dalam menjalani sisa hidupnya. Pernyataan ini juga didukung oleh Kuntjoro, 2012 yang menyatakan Dalam rangka membantu agar para lansia tetap beraktivitas dibutuhkan dukungan keluarga maupun sosial (Kuntjoro, 2012).

# BAB 5

## PENUTUP

Responden dari penelitian tentang edukasi kesehatan menggunakan multimedia interaktif adalah perempuan yang berumur 30-50 taun termasuk dewasa muda dengan latar pendidikan SMA, dengan pekerjaannya adalah ibu rumah tangga dan mempunyai hubungan dengan lansia sebagai anak.

Edukasi kesehatan menggunakan multimedia interaktif berperan penting dalam memberikan informasi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga yang mempunyai lansia dengan riwayat stroke dalam melakukan pendampingan untuk melakukan deteksi dini pencegahan risiko jatuh

Multi media interaktif adalah media yang merupakan gabungan dari berbagai elemen multi media seperti teks, gambar, suara, video yang dipergunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan edukasi, karena banyak manfaatnya seperti:

- 
1. Meningkatkan motivasi belajar
  2. Memperjelas materi
  3. Memudahkan pemahaman
  4. Membantu mengingat materi
  5. Melatih kemampuan
- 

Strategi penggunaan media interaktif ini dilakukan karena diharapkan responden akan mudah memahami dan mengerti terhadap konteks yang diberikan yang ditunjang dengan umur yang masih tergolong usia dewasa muda dan latar belakang pendidikan SMA yang sudah mampu dan melek

tehnologi mempunyai hubungan dengan lansia sebagai anak sehingga informasi yang diberikan akan mudah dipahami dan dimengert. Dan Penggunaan multimedia berupa modul dan video dapat meningkatkan kemampuan kader dan keluarga dalam melakukan pendampingan. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan difasilitasi dalam melakukan kegiatannya

Terdapat perbedaan bermakna kemampuan keluarga dalam deteksi dini risiko jatuh pada lansia kelompok intervensi sebelum dan sesudah pemberian edukasi multimedia interaktif dan pendampingan

kegiatan edukasi menggunakan multi media interaktif memberikan pengetahuan dan pemahaman pada keluarga dalam melakukan pendampingan pada lansia dengan risiko jatuh

Pendampingan keluarga pada lansia dengan risiko jatuh membutuhkan kesabaran, dan perhatian khusus karena beberapa factor yang mempengaruhi baik yang berasal dari dalam diri lansianya maupun luar diri lansia seperti factor lingkungan. Oleh karena itu Kader sebagai pendamping keluarga dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu menguasai tehnik-tehnik pendampingan dan tehnik lain yang berhubungan dengan pencegahan risiko jatuh pada lansia

## DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H. (2010). *Aplikasi asuhan keperawatan keluarga*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Ainy, R. E. N., & Nurlaily, A. P. (2021). Asuhan Keperawatan Pasien Stroke Hemoragik Dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis: Oksigenasi. *Journal of Advanced Nursing and Health Sciences*, 2(1), 21–25.
- Ahsan, Dima, N., & Prasiska, N. L. P. A. 2018. Hubungan Motivasi Perawat Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional Pencegahan Risiko Jatuh Di Ruang Rawat Inap. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 4(2). <https://doi.org/10.36053/mesencephalon.v4i2.86>
- Alifia, M. (2021). Gambaran Radiologi Pada Bidang Neurologis Stroke. Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram, Indonesia
- Ariastika Irine Sofyan, Heryanto Adi Nugroho, Rahayu Astuti (2011). Hubungan Antara Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Jatuh Pada Lanjut Usia Di Kelurahan Ngijo Gunung Pati Semarang. *Jurnal PIK KES Jurnal Keperawata* Vol. 4 No. 1 Maret 2011 : 18-29. Diakses 23 Nopember 2024
- Arief Mansjoer, 2016, *Stroke Non Hemmoragik*, Jakarta : Media Aesculapius
- Astuti, A.D., Sahar, J., & Sukihananto. (2013). *Hubungan dukungan keluarga dengan ualitas hidup lansia hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Jekan Raya Kota Palangkaraya*. Tesis. Depok: FIK UI.
- Azizah. (2011). *Keperawatan lanjut usia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Gambaran Kesehatan Lanjut Usia Indonesia*. Jakarta: Bakti Husada
- Chaidir R. & Zuardi M.I. (2014). Pengaruh Latihan Range Of Motion Pada Ekstermitas Atas Dengan Bola Karet

Terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragi Di Ruang Rawat Stroke RSSN Bukittinggi Tahun 2014  
Darmojo, B. (2011). *Buku Ajar Geriatric (Ilmu Kesehatan Lanjut Usia)*. Ed 4. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Depkes RI. (2009). *Sistem Kesehatan Nasional. Bentuk dan Cara Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan*. Jakarta.

Dewi, S.R. (2012). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Deepublisher

Faridah, U., Sukarmin and Sri, K. (2018) 'Pengaruh Rom Exercise Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Genggam Pasien Stroke Di Rsud Raa Soewondo Pati', 3(1), pp. 36–43.

Foroushani, A.R., Estebsari, F., Mostafaei, D., Ardebili, H.E., Shojaeizadeh, D., Dastoorpour, M., et al. (2014). *The effect of health promoting intervention on healthy lifestyle and social support in elders: a clinical trial study*. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16 (8).

Friedman, M., Bowden, V., Jones, E. (2010). *Keperawatan Keluarga: Riset, Teori & Praktek*. Ed 5. Jakarta: EGC.

Fristantia, D. A., Zulfitri2, R., & Hasneli, Y. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Resiko Jatuh Pada Lansia Yang Tinggal Di Rumah. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Keperawatan,

Gangavati, A., Hajjar, I., Quach, L., Jones, R. N., Kiely, D. K., Gagnon, P., & Lipsitz, L. A. (2011). *Hypertension, Orthostatic Hypotension, and the Risk of Falls in a Community-Dwelling Elderly Population: The Maintenance of Balance, Independent Living, Intellect, and Zest in the Elderly of Boston Study*. Journal of the American Geriatrics Society,

- Gunawan. (2012). *Penggunaan Simulasi Interaktif untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Mahasiswa pada Konsep Mekanika*. Jurnal Kependidikan. Vol 2 (1), 25-30.
- Haryono, R., & Utami, M. P. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah II*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
- Hever, J., & Cronise, R. J. (2017). Plant-based nutrition for healthcare professionals: Implementing diet as a primary modality in the prevention and treatment of chronic disease. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 355–368. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.012>
- Intan Diah Pramithasari, Puji Suwariyah 2 , Destianti Indah Mayasari.( 2021 ). Pengaruh Hidroterapi Terhadap Keseimbangan Tubuh dan Resiko Jatuh Pada Lansia. *JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan)* Oktober, 2021 Volume 5 No. 2
- Junior, A., Deniro, N., Sulistiawati, N. N., & Widajanti, N. (2017). *Hubungan antara Usia dan Aktivitas Sehari-Hari dengan Risiko Jatuh Pasien Instalasi Rawat Jalan Geriatri The Relationship between Age and Activity of Daily Living with the Fall Risk of Patients in Geriatric Outpatient Installation*. In *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* | (Vol. 4).
- Kanggeraldo, J., Sari, R. P., & Zul, M. I. (2018). *Sistem Pakar Untuk Mendiagnosis Penyakit Stroke Hemoragik dan Iskemik Menggunakan Metode Dempster Kementerian Sosial*. (2010). *Modul Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia (Home care)*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Kementrian kesehatan RI. 2019. Yuk, Mengenal Apa itu Stroke. diunduh dari <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stroke/yuk-mengenal-apa-itustroke> pada tanggal 24 November 2024
- Kementerian Kesehatan Indonesia Republik Indonesia. (2011). *Profil Kesehatan Indonesia 2010*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Khanjari, Y., & R.Garooei (M.A). (2015). Effects of hydrotherapy in balance and *prevention of falls among elderly women. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*,
- Mubarak.Faiz,Sandhika G.A.Fajar D.DS.(2017) Pembangunan aplikasi Multimedia Interaktif Pengenalan Jenis Permainan Tradisional ). Studi kasus,Skripsi. Bandung
- Munir, B., 2015, Neurologi Dasar. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Nies, M.A., & McEwen, M, (2001). *Community health nursing: Promoting the health of population (3rd ed.)*, USA: W.B. Saunders Company.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Notoatmojo, Soekidjo, (2010). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2013. *Ilmu kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar* Rineka Cipta. Jakarta.
- Novita. Dian ( 2016). *Pengaruh Penggunaan Mulyti media Interaktif Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siwa*
- Nurmalasari, M., Widajanti, N., & Dharmanta, R. S. (2018). Hubungan Riwayat Jatuh Dan *Timed Up and Go Test* pada *Pasien Geriatri. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*
- Periangan, Benardo. (2011).*Perancangan Media Interaktif Belajar Mengenal angka Bagi Anak Prasekolah*. Bandung : Universitas Komputer Indonesia
- Purnamadyawati , Farahdina Bachtiar. *Deteksi Risiko Jatuh dan Pendampingan Latihan Keseimbangan Pada Pasien Lanjut Usia di RS Setia Mitra Jakarta*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dikemas Vol. 4, No. 2 Tahun 2020
- Putrina, A. 2019. Analisis Perilaku Kepatuhan Perawat Dalam Re-Assesment Pasien Risiko Jatuh Dengan Pendekatan

- Theory Of Planned Behavior Di RSUD DR. Soetomo Surabaya (Vol. 53)
- Sadam Husein , Lovy Herayanti , Gunawan. 2015. *Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Terhadap Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Suhu Dan Kalor*. Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi (ISSN. 2407-6902). Volume I No 3, Juli 2015
- Sahar, J., & Rekawati, E. (2018). Effectiveness of Lafiska exercise on risk of fall, balance, and health status in the elderly. *Enfermeria Clinica*
- Setiyawan, S., Nurlaily, P. S., & Harti, A. S. (2019). Pengaruh Mirror Therapy Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Pada Pasien Stroke Di Rsud Dr. Moewardi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (JKM) Cendekia Utama*, 7(1), 49- 61
- Siti Nurul Rahayu , Yuli Isnaeni (2016) *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Risiko Jatuh Di Rumah pada Lansia Di Notoyudanrw 24 Pringgokusuman Yogyakarta*
- Suyasa Dharma. Kamaryati, Dina Susanti. (2016). *Studi Deskriptif Tentang Isi Panduan Pencegahan Dan Penanganan Jatuh Pada Lansia*. Unas Bali
- Tati, Nenden Rani Rinekasari, dan Yoyoh Jubaedah 2017 *Model Pendampingan Lanjut Usia Berbasis Home Care dalam Implementasi Pendidikan Vokasional*. Jurnal Teknobuga Volume 5 No. 2 – Desem
- Wardhana, W. . (2011). Strategi Mengatasi dan Bangkit dari stroke (Cetakan Pertama)
- Waras M. *Gambaran Tingkat Risiko Jatuh Pada Lansia Di Puskesmas Sedayu II Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta [Skripsi]*. Yogyakarta: Universitas Alma Ata Yogyakarta; 201



- Windi, A. S., & Donsu, J. D. (2018). Peneraan *Balance Exercise* Pada Lansia Dengan Gangguan Keseimbangan Tubuh di Bpstw Abiyoso Tahun 2018. (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
- Yueniwati, Y. 2016, 'Pencitraan Pada Stroke', Universitas Brawijaya Press, Malang

## GLOSARIUM

### **E.**

Edukasi kesehatan : proses pemberian informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk meningkatkan kesehatan

### **H**

*Home care, yaitu* adalah bentuk layanan kesehatan yang diberikan di rumah pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan, mencegah penyakit dan memaksimalkan kemandirian pasien, yang dilakukan oleh tim kesehatan dari berbagai profesi seperti dokter, perawat, ahli gizi dan rohaniah.

### **I**

IPTEK yaitu Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari perkembangan teknologi termasuk penemuan energi baru, dapat digunakan di berbagai bidang, seperti kesehatan, astronomi, dan teknologi.

### **K**

Kader adalah kader kesehatan yaitu warga yang dipilih oleh masyarakat bekerja secara sukarela yang dilatih untuk membantu pelayanan kesehatan dasar di komunitas dan bertanggung jawab ke masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat

### **L**

Lansia adalah istilah untuk menyatakan seseorang berumur 60 tahun atau lebih

### **M**

Multimedia interaktif adalah media digital yang dipergunakan dalam penyampaian pesan menggunakan penggabungan dari berbagai media seperti: teks, audio, video, gambar dan animasi sehingga pengguna mudah dalam berinteraksi dengan konten

secara dinamis dan mendalam.

## **P**

Pendampingan keluarga adalah upaya yang dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, terutama keluarga berisiko stunting. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) secara rutin setiap bulan.

PPT merupakan singkatan dari *PowerPoint*, sebagai aplikasi perangkat lunak, media yang dipergunakan dalam presentasi, sebagai salah satu media pembelajaran interaktif oleh guru/dosen, mahasiswa, manajer dan pembicara

## **R**

ROM merupakan singkatan dari *Range of Motion* yaitu Latihan rentang gerak atau latihan melatih otot atau persendian untuk pasien yang mengalami mobilitas sendi yang terbatas akibat penyakit, kelainan atau trauma

## **S**

Smartphone, yaitu telepon genggam yang bisa beroperasi seperti computer mini, pintar dan berkemampuan tinggi dan dapat dipergunakan mengakses internet, mengirim dan menerima pesan teks, email

Stroke adalah kondisi serius yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang

## PROFIL PENULIS



**(Aan Nurhasanah, SKM,MKM, Ketua Penulis)** Penulis adalah dosen tetap di Prodi Sarjana Terapa Promosi kesehatan Poltekkes Jakarta 3 Lahir di Kuningan , 14 Agustus 1964. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Ilmu Keperawatan. Universitas Indonesia tidak tamat. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sekolah

Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1988-1991 bekerja di sekolah Perawat Kesehatan di Jl. KS Tubun Cirebon. Dari tahun 1991-2013 di Keperawatan Anestesi, Jl Kimia 22-24. Pada 2013-2023 di jurusan keperawatan Poltekkes Jakarta 3, Program D3 Keperawatan. dari tahun 2023 sampai sekarang di jurusan kebidanan, Prodi STR Promkes. Poltekkes Jakarta 3. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Jakarta 3,Program Studi Promosi Kesehatan mengampu mata kuliah Psikologi dasar, Konseling , Pendidikan dan Latihan, PBAK,Manajemen Promkes, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis anggota Dampak Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Lansia, di publikasikan di nursing update jurnal ilmiah [VOL 14 NO 4 \(2023\): DESEMBER](#) , Psychoeducation Increasing Coping And Reducing The Famili's Burden Of Caring For The Elderly With Stroke Rehabilitation. Dipublikasikan di International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis volume 07 Issue 03 March 2024. Penulis Dapat Dihubungi Melalui email [annur1408@yahoo.co.id](mailto:annur1408@yahoo.co.id) atau [annur140864@gmail.com](mailto:annur140864@gmail.com).

## PROFIL PENULIS

**(Rosidawati, SKM.M.Kes Anggota Penulis)** Penulis adalah



dosen tetap di Prodi Sarjana Terapa Promosi kesehatan Poltekkes Jakarta 3 Lahir di Paringgonan Kec. Sipirok Sumatera Utara, 22-08-1962. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Urindo

Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000-2021 Sebagai dosen keperawatan Komunitas, tahun 2021 sampai sekarang sebagai dosen di Program Studi Promosi Kesehatan. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, mengampu mata kuliah Pengantar semografi, Manajemen Promosi Kesehatan dan Promosi Kesehatan di layanan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui email; [rosida1962@yahoo.co.id](mailto:rosida1962@yahoo.co.id).

## PROFIL PENULIS



**Eros Siti Suryati,SPd,MKM**, Penulis adalah dosen tetap di Prodi Sarjana Terapa Promosi kesehatan Poltekkes Jakarta 3. Lahir di Garut 13 Mei 1964 . menyelesaikan studi pada Akademi Keperawatan Dep.Kes Wijaya Kusuma.Jakarta Tahun 1994, S-1 Bimbingan Konseling Tahun 1999 di IKIP-JAKARTA, S-2 Kesehatan Masyarakat tahun 2011 di Universitas Indonesia. Saat ini penulis merupakan salah satu Dosen di Program Studi Promosi Kesehatan pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III (Poltekkes Kemenkes Jakarta III). Penulis dapat dihubungi melalui email: [eros.polkesjati@gmail.com](mailto:eros.polkesjati@gmail.com).

## Profil Penulis



**Nurdahlia, S.Pd, M.K.M.** Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Lahir di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1980. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Selain mengajar Bahasa Inggris di Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, penulis juga mengajar mata kuliah Bahasa Inggris di Prodi lain di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penulis aktif melakukan berbagai macam penelitian dan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang Promosi Kesehatan. Selain itu penulis juga aktif berperan sebagai *Adjudicator* (juri) dalam kegiatan kompetisi Bahasa Inggris tingkat nasional yang dilaksanakan setiap tahun baik oleh Kementerian Kesehatan (Poltekkes) maupun oleh Dikti (Politeknik) khususnya di bidang *English Debat*. Serta penulis menjadi Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa *English Club* pada Organisasi Kemahasiswaan sejak tahun 2016. Penulis dapat dihubungi melalui email: [lia.polkesjati@gmail.com](mailto:lia.polkesjati@gmail.com)

## SINOPSIS BUKU

Buku ini merupakan perluasan dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul **Edukasi Multi Media Interaktif Dan Pendampingan Keluarga: Kontribusi Penting Kemampuan Keluarga Dalam Deteksi Dini Risiko Jatuh Pada Lansia Stroke.**

Hasil penelitian menunjukkan bahawa peranan edukasi dan pendampingan pada lansia penting dalam pencegahan risiko jatuh karena Edukasi sebagai proses pembelajaran mempunyai tujuan memberikan pendidikan berupa pemberian informasi yang bersifat pengetahuan , sikap dan perilaku atau keterampilan dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik dalam aspek cara berpikir, bersikap bertutur kata dan berperilaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri, membantu melakukan sesuatu hal tepat dalam segala kondisi sehingga menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna

Pendampingan dapat dilakukan oleh keluarga pada lansia untuk mencegah risiko jatuh pada kegiatan berupa olah raga melatih keseimbangan, menjaga lingkungan yang aman dari mulai lantai, pencahayaan. Pengaturan barang-barang, Memasang pengaman di tempat tidur. Kegiatan ini sangat diperlukan sekali oleh keluarga sebagai pendamping lansia, karena dengan bertambahnya usia, risiko jatuh pada lansia dapat meningkat hal ini karena perubahan pada kondisi tubuh, mengabaikan kesehatan tubuh dan bahaya di dalam dan disekitar lingkungan lansia tinggal, riwayat kesehatan



Buku ini merupakan perluasan dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul Edukasi Multi Media Interaktif Dan Pendampingan Keluarga: Kontribusi Penting Kemampuan Keluarga Dalam Deteksi Dini Risiko Jatuh Pada Lansia Stroke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan edukasi dan pendampingan pada lansia penting dalam pencegahan risiko jatuh karena Edukasi sebagai proses pembelajaran mempunyai tujuan memberikan pendidikan berupa pemberian informasi yang bersifat pengetahuan, sikap dan perilaku atau keterampilan dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik dalam aspek cara berpikir, bersikap bertutur kata dan berperilaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri, membantu melakukan sesuatu hal tepat dalam segala kondisi sehingga menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna.

Pendampingan dapat dilakukan oleh keluarga pada lansia untuk mencegah risiko jatuh pada kegiatan berupa olah raga melatih keseimbangan, menjaga lingkungan yang aman dari mulai lantai, pencahayaan. Pengaturan barang-barang, Memasang pengaman di tempat tidur. Kegiatan ini sangat diperlukan sekali oleh keluarga sebagai pendamping lansia, karena dengan bertambahnya usia, risiko jatuh pada lansia dapat meningkat hal ini karena perubahan pada kondisi tubuh, mengabaikan kesehatan tubuh dan bahaya di dalam dan disekitar lingkungan lansia tinggal, riwayat kesehatan.

Penerbit:

**PT Nuansa Fajar Cemerlang**

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7097-56-9



9

786347

097569

